

إِسْمُ الْمَرِيضِ رِبَاعِيًّا : عُبَيْرٌ سَعِيدٌ مُحَمَّدٌ جَمْعُهُ

المحافظة : القاهرة ٥

الحى / المدينة : البساتين

العنوان : ---

رقم البطاقة : 28605100100287 رقم التلفون : 01223227918

تاريخ تسجيل الإستمارة : 03-10-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 10-05-1986 المهنة : ربه منزل

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (-----) التوقيع: (-----)

المقرر بما فيه التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة
[11129]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

الوظيفة: ----- التوقيع:

الوظيفة: ----- التوقيع:

الوظيفة: ----- التوقيع:

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

----- / ۲ ----- / ۲ ----- / ۲.۱ ----- / ۲.۱

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطّة العلاج :

المستشفى :

جھة العلاج : --

ملاحظات : ----

ختم

شعار الجمهورية

مدير عام

مديرية الشؤون الصحية

رئیس

المجلس الطبي المتخصص

--

Name: عبير سعيد محمود جمعه National ID: 28605100100287	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



عبيد
سعيد محمود جمعة
أش علي حامد- مربة إسكندر
البيسنتين - القاهرة

١٩٨٦/٠٩/١٠ ٢٨٦٠٥١٠٠١٠٠٢٨٧
KE0348456

٢٠٢٣/٠٩ ٢٨٦٠٥١٠٠١٠٠٢٨٧

بدون عمل

أنثى مسلمة متزوجة
حماده صلاح علي أحمد مرمي
البطاقة مارية حتى ٢٠٣٠/٠٩/١٢





Patient ID: 11111111
 Name: J. J. J. J. J.
 Date of Birth: 11/11/11

Family history: No
 Marital status: Single
 Comorbidity: No

Breast Imaging

DX: IDC
 ER: 6/8
 PR: 5/8

T: 2
 N: 1

Sonohammography

PATIENT HISTORY

PREMENOPUSAL RT BC WITH HEVILY DEVELOPPED QUERT MEDIASTINAL LHS
 HISTORY: RT BC CT2N1M0,,RECEIVED 16 VIX 11.5AMP
 LAST ONE ON 16/12/2022-->RT MRM --> 17/11/2021 VIG
 PT RECEIVED 14 CYCLES OF HERCEPTIN + EPIDITA
 CT CHEST 1/8-->MEDIASTINAL AND HILAR LHS
 xeloda x 8 cycle + tykerb x 6-->RD
 received 3 cycle anvelbina + tykerb --> PT 1/7/2024 med LN 1.5 x 0.7
 ct 4/2024:SD med LN 1.5 x 0.7

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

maintenance tykerb zoladex aromatase

MEDICAL ONCOLOGY

SURGERY

Psychiatric

SIGNATURE

PATHOLOGIST

PATHOLOGIST

MDT OUTCOME

Patient Name :
Patient No. : 28605100100287
Path No. : 3792/22
Sex : Female
Age : 36 Y
Referring Doc :

Request No. : 13007100
Request Date : 17/12/2022
Verification Date : 25/12/2022
Financial Category : أورام دار السلام - فئة الدولة
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

CLINICAL DATA: Right breast cancer post NACT

NATURE OF SPECIMEN: Right MRM

GROSS EXAMINATION:

- Procedure: Right MRM specimen measured 26x17x6 cm with covering skin ellipse measured 23x23 cm
- Tumor extent : cut section revealed clipped UOQ ill defined rubbery tumour bed site.
- Size: 3.5x2.5x2 cm
- Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly
- Distance from margins: 2cm away from deep margin and 3cm from skin.
- Lymph nodes number and size: (9) Ns up to 2.5x2 cm .

MICROSCOPIC EXAMINATION:

- Histological type: No residual viable tumour tissue detected
- Skin involvement: Free nipple and areola
- Lymph node involvement: Two nodes showed scattered tumor cells (<200 cells, <2mm).
- Resection Margins: Free margins
- Histologic response to therapy: Pathologic complete response

DIAGNOSIS:

Right MRM (post NACT):

No residual viable tumour tissue detected .

Free margins

Free nipple and areola

Lymph nodes status: Two nodes showed scattered tumor cells (<200 cells, <2mm).

Pathologic complete response (PCR) - 1^{mic}

Stage : ypT0 , ypNmic , ypMx.

(2/9)

Verified by :

Dr. Manwa mahmoud

Patient Name: Abeer Saeed Mahmoud Gomaa	Date : 11/03/2025
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 39 Year(s)
Medical ID: 2622/2022	Pat. ID: 15107

**POST-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE
CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -**

*known case of right mastectomy, Compared to the
previous study dated 17/09/2024.

Chest:

- Right mastectomy with no gross operative bed masses.
- **Rather stationary course** regarding the few enlarged bilateral hilar and mediastinal lymph nodes, The largest is right paratracheal still measuring about 1.5 X 0.7 cm
- **Still noted** middle lobar subpleural thick reticulations and coarse atelectatic changes mostly representing post radiation sequel.
- No sizable pulmonary nodules in today's study.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal enhanced CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

Abdomen and pelvis:

- The liver is still seen mildly enlarged with homogenous CT texture. No definite enhanced focal lesions or biliary radicles dilatation
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.